Abdominal pain
腹痛衛教
如何在家照顧自己？
記錄疼痛情況，記錄疼痛發生前和發生期間的活動。如果疼痛與食物相關，記錄具體的食物種類。
飲食調整，少量多餐。如果有便秘，增加纖維攝入並多喝水。
避免加重疼痛的食物或飲品，如碳酸飲料、含咖啡因或酒精的飲品，油炸、油膩或高脂肪食物，柳橙汁等酸性飲料，牛奶或奶酪。
緩解疼痛的方法：嘗試排便。躺下休息。暫時避免固體食物，如果感到餓，可嘗試喝肉湯或水。當感覺好轉時，可以逐漸試著吃米飯、餅乾、香蕉、蘋果醬或吐司等清淡食物。
除非醫生建議，否則避免自行使用非處方藥物，例如：自行服用制酸劑或瀉藥。在服用任何草藥或營養補充品之前，請先諮詢醫生。

什麼時候應該尋求緊急醫療的幫助，或打電話叫救護車？
出現以下症狀請您立即呼叫緊急救護協助：
突然出現嚴重腹痛或持續的腹痛。
腹痛伴隨呼吸困難或胸痛。
吐血或排出大量血便。
腹部非常硬或腫脹。
腹痛且發高燒達 39˚C 以上。

若發現以下情況，應及時返回急診評估治療：
有嚴重脫水的跡象，例如超過 8 小時未排尿。
感到非常頭暈或要昏厥。
感到虛弱，似乎站立不穩。
腹痛加重、頻率增加或集中在某個部位。
持續的噁心或嘔吐，且無法正常進食或飲水。
排黑色或瀝青樣的糞便。
這些症狀可能表明潛在的嚴重健康問題，需要及時的醫療介入。

若發生以下情況，請至醫院或診所就醫看病：
腹部疼痛持續 1 到 2 天未消失或未改善。
出現發燒 38˚C 以上或寒顫。
出現脫水跡象，例如：尿液顏色非常深、嘴巴乾燥或肌肉痙攣。
感到疲倦。
起身時感到頭暈。
排尿時疼痛或尿液中有血。

排便時帶有少量血液（少於 1 茶匙或 5 毫升）。
感覺腹部有異常。
出現新的症狀或原有症狀惡化。
若發生以上症狀，請及時就醫以預防潛在的問題惡化，並請確保您得到適當的治療。

AGE, acute gastroenteritis, viral gastroenteritis
腸胃炎衛教，病毒性腸胃炎衛教

什麼是病毒性腸胃炎？
病毒性腸胃炎是一種會導致腹瀉和嘔吐的感染疾病。當病毒感染了胃和腸道，就會引起這種疾病。諾羅病毒（Norovirus）是最常見的病毒之一，但其他病毒也可能造成腸胃炎。

以下狀況可能導致感染病毒性腸胃炎：
接觸感染病毒的人或帶有病毒的物體表面後，沒有洗手。
食用被病毒污染的食物或飲料。如果感染者未妥善洗手，病毒可能會透過接觸食物或飲料而傳播。

病毒性腸胃炎的症狀有哪些？
病毒性腸胃炎的典型症狀為腹瀉和嘔吐，可能同時或單獨出現。症狀通常發生突然且可能很嚴重。

病毒性腸胃炎還可能伴隨以下症狀：
發燒、頭痛或肌肉痠痛、腹部疼痛或痙攣、食慾不振，如果腹瀉和嘔吐症狀嚴重，身體可能會因失去過多水分而造成脫水。脫水會導致口渴、疲倦、頭暈甚至意識混亂，尿液顏色也可能變得深黃，嚴重脫水甚至可能威脅生命，特別是年長者更容易出現嚴重脫水的情況。

我需要進行檢查嗎？
通常不需要特殊檢查。醫師會透過詢問症狀與理學檢查即可判斷是否為病毒性腸胃炎。但有時醫師可能會進行檢查來評估脫水程度或確認是哪種病毒感染，例如：血液檢查、尿液檢查或糞便檢查。

我可以自己做些什麼來緩解症狀？
您需要補充因腹瀉和嘔吐流失的水分：
盡量補充水分。每 15 至 30 分鐘少量飲用，症狀好轉後逐漸增加飲水量。
嚴重嘔吐或腹瀉時，身體會同時流失水分和鹽分，建議補充含有適當鹽分的液體，例如口服電解質水（口服補液鹽）或清淡的湯類。如果只喝大量的純水，務必要進食，以維持體內水分和鹽分的平衡。
避免飲用含大量糖分的飲料，如果汁或汽水，也應避免飲酒。
狀況允許時，盡量進食容易消化的食物，例如瘦肉、水果、蔬菜、全麥麵包和穀物。避免高油脂或高糖食物，以免加重症狀。
若你是 65 歲以下的成人且腹瀉症狀剛發生，沒有發燒或糞便帶血，可以短暫

（1 至 2 天）使用止瀉藥物如洛派丁胺（Loperamide, 商品名：Imodium）。但若你超過 65 歲、有發燒或糞便帶血，在使用止瀉藥物前應先諮詢醫師。

如果你患有糖尿病，症狀期間可能需要更頻繁地監測血糖，直到情況好轉，建議與醫療人員討論。

什麼情況下應該立即至醫院接受評估治療？

若出現以下情形，請立即至醫療院所就醫：

出現脫水症狀，如非常疲倦、口渴、頭暈或意識混亂

腹瀉或嘔吐持續數天以上未改善

嘔吐物帶血、腹瀉帶血或出現劇烈腹痛

已經好幾個小時無法補充任何液體

已經 6 至 8 小時沒有排尿（白天時間）

病毒性腸胃炎如何治療？

大部分患者不需特殊治療，症狀會自行改善。但嚴重脫水的患者可能需要住院接受靜脈注射（俗稱打點滴）補充液體。抗生素並無法治療病毒性腸胃炎，因為抗生素僅針對細菌感染有效，對病毒無效。

腸胃炎能否預防？

在某種程度上可以預防。為降低感染或傳播病毒的風險，請在如廁後、用餐前或準備食物前，以肥皂和清水徹底洗手，此外，換尿布後務必徹底洗手，且避免在烹飪或進食區域附近更換尿布。

Burn injury
燒燙傷衛教

熱液(開水或熱湯等高溫液體)燙傷的原則，口訣：沖脫泡蓋送
沖:儘快將受傷部位浸泡在冷水內,或用流動的自來水沖洗,需沖洗 15-30 分鐘以上,以快速降低皮膚表面熱度。
脫:將身上衣服充分泡濕後,再小心脫掉,盡量避免把水泡弄破。
泡:接下來把受傷部位浸泡在冷水中,可減輕疼痛。若燒傷面積太大或年齡太小,則不可浸泡,以免體溫下降過低,產生心臟不規則跳動等併發症。
蓋:把清潔乾淨的棉布用煮沸過的冷開水沾濕,覆蓋受傷部位。保持傷口部位乾淨,不要在受傷部位塗抹任何東西,以避免傷口感染。
送:儘速送往鄰近醫院做進一步的處理。

火焰燒傷
若身上著火,應立即用雙手掩住臉部,就地臥倒翻滾,或以大塊布巾包住,等火熄後再依上述熱液燙傷急救方式處理。著火後切忌到處奔跑,這樣只會迎風而助長火勢。

接觸燒傷
接觸燒傷一般都屬較輕程度的燒燙傷，處理方式如下：
將燒、燙傷部位放在自來水下輕沖洗或浸於冷水中約 30 分鐘,到不痛為止,如無法沖洗或浸泡,則可用乾淨的水冷敷。
傷處未腫脹前,小心脫除戒指、皮帶、鞋子或其它緊身衣物。
必要時可以使用敷料並加以包紮。
不可使用黏性敷料。
不可在傷處塗抹乳液、軟膏、油脂、牙膏、醬油。
不可弄破水泡,也不要剝除鬆離的皮膚或干擾傷處。

化學傷
無論化學劑的成分酸鹼度如何,受傷後要立刻以大量自來水沖洗受傷部位,沖洗時避免化學劑擴散至未受傷部位,沖水時間至少 30 分鐘,以降低皮膚表面的化學劑濃度。
若波及顏面特別是眼睛,應睜開眼睛用大量自來水沖洗以稀釋濃度。

電傷
電傷是由於電流通過人體組織,所遭遇電阻而受傷。嚴重度依電流通過人體組織的時間和通過路徑而定。如果心臟或呼吸中樞受損,則發生心跳及呼吸停止,腦神經受損將造成意識障礙,甚至死亡。

切記急救前要先確定電源已被切斷。發現呼吸及心跳停止時,應立即施行心肺復甦術及人工呼吸,同時立即送醫治療。
除非是電弧燒傷,一般而言,電傷程度較深,可不必經過沖水過程,應直接送醫治療。

Chest pain

胸痛衛教

當您的胸痛出現以下情況時，請立即尋求醫療協助：

您的胸痛是新發生的、嚴重的或持續惡化的。

胸痛伴隨著呼吸急促或呼吸困難。

胸痛在休息後仍未緩解。

服用心絞痛藥物後，胸痛仍未緩解。

您感到頭暈或昏厥。

您的症狀讓您感到害怕或擔憂。

這些症狀可能是危及生命的警告信號，需要及時處理。

Constipation
便秘衛教
我應該知道什麼？
您來到急診科是因為便秘。便秘是指大便過於堅硬、過小或不夠頻繁，也可能會發現排便困難。
大多數時候，您可以在家裡處理便秘。

如何在家照顧自己？
食用高纖維的食物。好的選擇包括水果、蔬菜、李子汁和穀物。
多喝水和其他流體。
當您有排便的感覺時，請立即上廁所。不要忍耐。
嘗試在早晨或用餐後不久進行排便。
當您試圖排便時，某些姿勢可能會有所幫助。嘗試稍微前傾，並在腳下放置凳子或腳踏板。
嘗試保持規律的身體活動與運動。一些人發現這樣規律的運動有幫助於排便。
請由醫師評估後再決定是否經常使用瀉藥或灌腸。

什麼時候應該立刻尋求緊急醫療的協助？
若有以下狀況請立即送醫：
若您突然感到劇烈腹痛，或疼痛持續不斷。
您的腹部變得非常硬或鼓脹。
您有吐血的狀況。
您的排便中有大量的血液，超過 1 茶匙或 5 毫升。

如果發生以下情況，請您至急診評估治療：
您的排便呈黑色或瀝青焦油色。
您有大量嘔吐且無法攝入水分，呈現脫水狀態。
您有發燒達到 39˚C 或更高。

什麼時候應該考慮看醫生？
您發燒達到 38˚C 或更高，或感到寒顫。
您的排便中有少量血液，不到 1 茶匙或 5 毫升。
您覺得腹部有異常情況。
您有痔瘡，痔瘡是直腸內的腫脹靜脈，可能引起搔癢、出血和疼痛。
您有超過 2 週的硬便和腹痛。
您有新的或加重的症狀。
若有以上症狀請至醫院或診所評估治療。

Cough

當您的咳嗽出現以下情況時，請及時尋求醫療協助：
呼吸困難或呼吸時有異常聲音，例如喘鳴音。
出現發燒或胸痛。
咳嗽時咳出血液，或黃色或綠色的黏液。
咳嗽劇烈到引發嘔吐。
咳嗽加重或持續超過 14 天。
咳嗽且出現不明原因體重減輕的情況。
這些症狀可能表明潛在的嚴重健康問題，需要及時處理。

咳嗽衛教:
在家如何自我護理、照顧？
如果咳嗽是由感冒引起的，維持環境的空氣濕度在 50%-60%之間。
考慮含喉糖，緩解喉嚨的不適感。
喝溫熱飲品，例如溫開水，有助於舒緩喉嚨。
避免吸煙或接觸二手煙，遠離吸煙環境。
如果有過敏症狀，避免接觸過敏源，例如花粉、灰塵、動物或霉菌。
如果咳出痰液，可嘗試非處方的感冒咳嗽藥，這些藥物可能有助於稀釋黏液並減少咳嗽的衝動。
如果有胃酸逆流，請與醫師或護理人員討論減少症狀的方法，例如考慮藥物治療，飲食調整，吃飯吃七分飽，吃完飯後不要馬上躺著。

咳嗽如何治療？
如果感染是由細菌引起的咳嗽，醫生可以用抗生素治療。但如果感染是由病毒引起的，抗生素無效。對於某些病毒感染，如流感或新冠肺炎病毒 COVID-19，可能有其他藥物可以幫助。
如果咳嗽是因為鼻涕倒流引起的，可使用不同類型的藥物治療，這些藥物可以是口服藥或鼻噴劑。
哮喘 Asthma 和慢性阻塞性肺疾病 COPD，可使用吸入型藥物治療，這些藥物透過吸入進入肺部。
如果是因胃酸逆流引起的咳嗽，可使用減少或抑制胃酸的藥物進行治療。
如果咳嗽是由於服用 ACE 抑制劑引起的，醫生可以更換其他藥物。

Delirium, Confusion

譫妄、意識混亂衛教

什麼是譫妄？

譫妄是一種腦部障礙，會使人感到困惑，「困惑」這個詞意味著一個人無法清晰地思考。醫生在談論譫妄時，可能會使用其他術語。他們有時會用「改變的心理狀態」來形容當一個人的大腦運作異常時的情況。

譫妄的症狀有哪些？

譫妄的人可能會感到昏昏欲睡，或是很難被喚醒；也可能比平時更活躍或焦躁不安，甚至有時候他們會看到或聽到實際上不存在的事物。

患有譫妄的人還經常會有以下症狀：

對於人、時、地有錯誤的認知，難以知道自己在哪裡、是什麼時候，或周圍的人是誰。

難以集中注意力，或無法將注意力從一件事轉移到另一件事。

記憶、語言或其他思考方面的問題。

譫妄的症狀會迅速出現，通常在幾個小時或一兩天內發展。症狀可能會在一天內反覆出現，並且通常在一天結束時變得更嚴重。這是譫妄與「癡呆症」的區別之一，癡呆症是一種記憶和思維問題的腦部障礙。癡呆症的症狀會非常緩慢地出現，並在幾個月或更長的時間內逐漸惡化。

譫妄更常發生在以下族群：

年紀較大、有許多健康問題或服用很多藥物的人，

患有腦部疾病的人，例如癡呆症，

有視力或聽力問題的人，

譫妄最有可能發生在住院的病人身上，尤其是當他們剛做完手術或正在經歷疼痛。

譫妄接受過治療後，在家中需要什麼幫助？

當病人譫妄接受過治療後，如果回家，他們可能仍然需要幫助。

如果你在照顧一位患有譫妄的人，你可能需要做到以下事項：

定期查看關心他們，確保他們的安全。

確保他們按指示服用藥物。

保持他們的環境安靜和舒適。

確保他們有足夠的睡眠。

幫助他們準備餐點。

帶他們按時間回診。

請記下病患的生活作息與反應的變化，這些可能包括：
他們對周圍發生的事情的理解程度。
睡眠習慣的變化。
他們是否有記憶問題?
他們是否難以集中注意力?
他們情緒的變化。
他們說話的變化，包括無法說話或聽起來令人困惑。
排尿或排便控制的問題，例如大小便失禁。
無法控制自己的動作。
做到以上事項將有助於病人康復。

譫妄可以預防嗎？
有時候可以，醫生會採取一些方式來降低住院病人罹患譫妄的機會，這些方法可能包括：
避免某些藥物。
在夜間讓病人的房間保持安靜，幫助他們入睡。
如果病人習慣佩戴眼鏡或助聽器，則白天提供這些設備。

應該注意哪些問題？
如果一個曾經接受過譫妄治療的人出現以下情況，應該至醫療院所尋求協助：
困惑持續超過 10 分鐘。
心跳非常快。
冒冷汗。
出現異常的想法。
視覺或聽覺出現幻覺，看到或聽到並不存在的事物。
若出現以上情況，應帶病患至醫療院所尋求協助。

Diarrhea
腹瀉衛教
腹瀉是什麼？
腹瀉是指排便呈現稀薄或水樣狀，並且一天發生三次或更多次。

我可以在家自己做些什麼來改善嗎？
可以嘗試喝大量含有水分、鹽分和糖分的液體。好的選擇包括水混合果汁、風味汽水和湯汁，如果你的尿液顏色會是淺黃色或幾乎透明，代表你攝取了足夠的水分。也可以嘗試吃一些食物，好的選擇包括馬鈴薯、麵條、米飯、燕麥片、餅乾、香蕉、湯和煮熟的蔬菜，鹹食也有幫助。

何時需要看醫生？
如果您出現以下情況，請及時就醫：
24 小時內有超過 6 次水樣便。
大便中有血。
發燒超過 38.5˚C，且一天後仍未退燒。
腹部疼痛劇烈。
年齡在 70 歲或以上。
若身體失去過多水分，稱為「脫水」狀態，脫水的症狀包括：大量水樣腹瀉、感到非常疲倦、口渴、口乾或舌頭乾燥、肌肉痙攣、頭暈、意識混亂、尿液顏色非常黃，或超過 5 小時無尿。

如何預防腹瀉？
您可以通過以下方法減少感染和傳播腹瀉的風險：
保持良好的手部衛生，在完成以下情況後記得洗手：換尿布、烹飪、進食、上廁所、倒垃圾、接觸動物，以及擤鼻涕後。
生病期間避免接觸他人，在康復之前，請待在家中，不要上班或上學。
注意食品安全，不要飲用未經消毒的牛奶或使用其製成的食品。
食用前徹底清洗水果和蔬菜。
將冰箱的溫度保持在低於 4˚C，冷凍室保持在低於-18˚C。
將肉類和海鮮徹底煮熟。
將雞蛋煮至蛋黃凝固全熟。
接觸生食後，洗手並清潔刀具及砧板。
這些措施有助於降低感染和傳播腹瀉的風險，並促進整體健康。

Dizziness
頭暈衛教
什麼是頭暈？
頭暈對不同的人可能有不同的感覺，您可能會感到頭昏眼花或者像快要昏倒一樣，您也可能會發現自己走路不穩，或覺得自己快要跌倒，有些人則會感覺像是自己在旋轉，或是周圍的世界在旋轉，這種旋轉感覺叫做「眩暈」(Vertigo)。

許多因素可能會讓您感到頭暈，有些是嚴重的情況，如心臟問題或中風，也有一些較不嚴重的原因，例如起身太快或沒有喝足夠的水，這些也可能導致頭暈，而某些藥物也可能引起頭暈。

如何在家中照顧自己？
如果您有眩暈，醫生可能會給您一些藥物來幫助緩解症狀。
如果醫生告訴您需要回診，請按照預約的門診時間回診。
避免快速變換姿勢，例如從坐著變成站立時要小心緩慢。
起身前，可以先坐在床邊幾分鐘，然後再慢慢站起來。
如果您需要長時間坐著或站著，請經常移動腿部。
即使不感到口渴，也要喝足夠的水分。
如果您感到暈眩或快要昏倒，應立刻坐下或躺下，請特別小心，避免跌倒。如果您在駕駛時感到頭暈，應立儘速路邊停車，並按下汽車三角警示燈。
如果您感到頭暈，使用拐杖或助行器行走，或者請他人幫助您走路，以防跌倒。

若有頭暈症狀，何時應該叫救護車尋求急診幫助？
如果您出現以下症狀請儘速送醫評估：
出現手腳無力
有新的言語、吞嚥、視力或聽力問題
感到胸痛、心跳不規則或呼吸困難
出現癲癇發作
因頭暈而無法走路或站立

若有頭暈症狀何時應該到醫院就診？
如果您的頭暈持續很長時間或惡化，或是出現新的或加重的症狀，請至醫療院所就醫。

Edema
水腫衛教
什麼是腫脹(或稱為水腫)？
腫脹是指體內組織和器官周圍的小空間中積聚液體的情況，腫脹的另一個名稱是「水腫」，一些常見的會發生腫脹(水腫)的部位包括：下肢或手部，腹部，胸部(水腫可能出現在肺部或肺部周圍的空間)
下肢、手部和腹部的腫脹可能會引起不適，並可能是更嚴重病狀的徵兆。肺水腫可能是危及生命的，因為它通常是心臟問題的症狀。

腫脹(水腫)的症狀有哪些？
腫脹(水腫)的症狀包括：
皮膚腫脹，可能導致皮膚看起來被拉伸並發光，這通常會發生在下腿或下背部的腫脹，並且在長時間坐或站立後可能會加重。
腹部增大（腹部腫脹）
呼吸困難（胸部腫脹）

何時應該到醫療院所就醫看醫生？
如果您有新的以下腫脹(水腫)症狀，應該到醫療院所就醫：
非長時間坐著或躺著，卻在一條或兩條腿上發生新的水腫，或是在手部上、在腹部上或是在眼睛周圍的腫脹，如果您旅行並長時間坐著，然後出現腿部疼痛或腫脹，且幾天後無法消退，也應該看醫生。

腫脹(水腫)怎麼治療？
醫生會根據腫脹的原因採取不同的治療方法，治療可能包括以下方法：
治療導致腫脹的醫療狀況，
改變飲食，減少食物中的鹽分，
使用幫助身體排除多餘液體的藥物，
特殊的襪子，稱為「壓力襪」，這些襪子緊緊地包裹在腳踝和腿部，能減少腿部腫脹。如果醫生或護士建議您穿這些襪子，他們會告訴您應該穿哪種類型並如何穿上。
抬高雙腿，有些人可以透過每天 3 到 4 次、每次抬高雙腿 30 分鐘，來減少腿部、踝部和腳部的腫脹，雙腿需要抬高到高於心臟的位置。
並非所有類型的腫脹都需要治療。例如，懷孕期間或月經前的腫脹通常不需要治療。
以上方式有機會改善水腫狀況。

如何在長途飛行時幫助預防腿部腫脹？
為了幫助預防超過 6 到 8 小時的長途飛行中的腿部腫脹：

每隔 1 至 2 小時起來走動，旅行前不要抽煙，穿寬鬆舒適的衣物，經濟上允許的話，選擇較大可讓雙腳伸展活動的座位，不時地伸展腳趾、踮腳和彎曲膝蓋。喝足夠的水，避免飲酒。不要服用會讓您無法起身走動的藥物，例如安眠藥。

以上方式皆有預防腿部腫脹的效果。

Epistaxis, Nosebleeds
流鼻血衛教

為什麼人會流鼻血？
當血液從你的鼻子或孩子的鼻子流出時，可能會讓人感到害怕。但鼻血通常不嚴重，而且非常常見。最常見的原因是乾燥的空氣和挖鼻子，只要處理得當，大多數鼻血會自行停止。

如何判斷鼻血是否嚴重？

如果你的流鼻血有以下情況，請立即就醫：
呼吸困難，
流鼻血讓你變得非常蒼白，或讓你感到疲倦或困惑，
即使按照下面所述的步驟處理，鼻血仍無法停止，
鼻血發生在鼻部手術後，或如果你知道自己有鼻部腫瘤或其他生長物
與其他嚴重症狀一起發生，例如胸痛
在重大傷害後發生，如車禍或重擊面部
鼻血持續不止，並且你正在服用預防血液凝結的藥物，例如 Warfarin 華法林 (商品名稱：脈化寧)、Dabigatran 達比加群 (商品名稱：普栓達 Pradaxa)、Apixaban 阿哌沙班，商品名 Eliquis)、Rivaroxaban 利伐沙班 (商品名稱: Xarelto 拜瑞妥)、Clopidogrel 氯吡格雷 (商品名稱：Plavix 保栓通) 或每日服用 Aspirin 阿斯匹靈
如果你流鼻血且有以上情況，請立即就醫。
如果你有流鼻血且感到胸痛、呼吸困難或頭暈，請撥打緊急電話 119 叫救護車送至急診就醫。

如何自行止住鼻血？
只要進行正確的自我處理，大多數鼻血會自行停止。以下是你應該採取的步驟：
坐下，並稍微彎腰向前，不要躺下或仰頭。
用手指捏住鼻子的鼻翼軟骨部位，即鼻骨下方，不要捏住鼻樑部位，這樣做不會有效，即使流血只發生在單側鼻孔，也不要只按壓一側，這樣也不起作用，要捏住雙側鼻翼。
持續捏住鼻子至少 15 分鐘，對於年幼的孩子，照顧者應安撫孩子並捏住他們的鼻子，在時間到之前不要鬆開壓力來檢查流血是否停止，如果一直檢查，會影響止血的效果。
考慮冰敷鼻樑位置。

採取以上步驟，大多數鼻血會自行停止，如果你按照這些步驟做，鼻血還是繼續流，請再重複一遍所有步驟，加壓捏住鼻子至少持續 30 分鐘，如果鼻血仍未停止，請前往急診或緊急照護醫療診所。

頻繁流鼻血的原因可能包括：
長時間呼吸乾燥的空氣
過度使用冷或過敏的鼻噴劑
經常感冒
挖鼻子
吸食毒品，例如古柯鹼、海洛因
在某些情況下，反覆流鼻血可能是血液無法正常凝固的跡象，如果是這樣，通常會有其他線索，例如，血液凝固有問題的人容易瘀傷，牙齦出血，在小割傷或擦傷後出血比預期更多。

流鼻血在醫院會怎麼處理？
如果你看醫生或護士，他們會確保你能正常呼吸，並且可能會需要在你的鼻子內放置一些紗布或止血材料。

我該如何預防鼻血？
您你可以考慮在睡覺時在臥室使用加濕器(使空氣不那麼乾燥的機器)，
使用鼻用鹽水噴霧、凝膠或凡士林(市售品牌名稱：Vaseline)保持鼻腔內部濕潤。
不要挖鼻子，或者至少在挖鼻子前修剪指甲，以避免受傷。
如果你在過去 24 小時內曾流過鼻血，你應該避免下述活動：重物搬運、低頭、用力擤鼻，避免喝熱湯或熱食，這些活動可能會再次引起鼻血。

Fever
發燒衛教
什麼是發燒？
發燒是指體溫升高超過一定溫度，一般來說體溫超過 38˚C 或中心體溫超過 38.3˚C 即為發燒，根據測量方式位置的不同（例如：口腔、腋下、耳朵、額頭或直腸），溫度數字可能略有不同。

什麼引起發燒？
成年人發燒最常見的原因是感染，常見可能引起發燒的感染包括：COVID-19，感冒或流感，肺部感染的肺炎，腸胃病毒等。

發燒應該如何在家照顧自己？
多喝水、果汁或高湯，以補充因發燒流失的液體。
穿輕薄的衣服，如果感覺冷，可以用輕薄床單或毯子覆蓋。
服用退燒藥，例如：乙醯胺酚 (英文學名：Acetaminophen，商品名稱：普拿疼)、 布洛芬 (英文學名: Ibuprofen，商品名稱：伊普芬) 或是其他非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs) 來幫助降低體溫，緩解不適。
在沒使用退燒藥情況下，退燒未達 24 小時前。如果您的發燒具有傳播力，請儘量待在家中，這有助於防止傳染給其他人。
經常洗手，咳嗽或打噴嚏時，請用紙巾或肘部遮住，而不是用手，與他人接觸時，可考慮戴口罩，以保護周圍人群的健康。
如果醫生有安排後續回診追蹤，請按時間回診評估。

什麼時候應該立即到急診就醫或呼叫救護車？
出現以下情況時您應該立即到急診就醫評估治療：
發燒達到 38˚C 或以上，並且伴有以下症狀：呼吸困難，嚴重頭痛和頸部僵硬，出現意識模糊，癲癇發作，或是出現嚴重脫水的跡象，例如：超過 8 小時沒有排尿，感到非常頭暈或似乎要昏倒，感到虛弱像是要摔倒的狀況。
若出現以上狀況，應該立即到急診就醫評估治療。

何時應該到醫療院所就醫看醫生？
若出現以下症狀時，請您到醫療院所就醫評估：
發燒達到 38˚C 或以上，反覆發燒持續多日。
出現早期脫水跡象，例如：尿液顏色深，嘴巴乾燥，肌肉痙攣，全身虛弱無力，或是起身時感到頭暈。
出現皮疹。
出現腹痛、嘔吐或腹瀉。

出現新的或惡化的症狀。
若出現以上症狀請至醫療院所就醫評估治療，及早處理潛在問題。

Flank pain
腰痛衛教
什麼是腰部疼痛？
腰部疼痛是指肋骨和臀部之間的側邊和背部的疼痛，腰部疼痛可能由不同原因引起，可能逐漸出現或突然開始，且程度可輕可重，疼痛可能出現在身體的單側或兩側腰部，腰部疼痛的感覺可能是鋒利的、抽筋樣的，也可能是鈍痛或持續性的，一些人在捲曲成球狀時疼痛會緩解，而另一些人則需要平躺且保持不動靜止，有些人可能因疼痛感到噁心或嘔吐。
有時候腰部疼痛可能非常劇烈，以至於影響活動或呼吸，嚴重的腰痛可能是醫療緊急情況，應即時就醫評估檢查與治療。

我應該知道什麼？
您因腰部疼痛（flank pain）來到急診室。這是指肋骨和臀部之間側部和背部的疼痛。腰部疼痛可能由不同原因引起，可能逐漸出現或突然開始，且程度可輕可重。疼痛可能出現在身體的一側或兩側。

醫生可能會認為您的腰部疼痛不太可能由嚴重疾病引起，不過可能無法在第一次就診時確定病因，因此，後續門診追蹤是非常重要的。

如何在家照顧自己？
按照時間回診。
記錄疼痛發作的時間和情境，幫助醫生更好地了解原因，記錄您的飲食，看看是否有可能因為食物引發疼痛。
避免吃可能讓疼痛加劇的食物和飲品，例如：碳酸飲料和含咖啡因的飲品，油炸、油膩或高脂肪食物，牛奶和乳製品（如奶酪、冰淇淋）
可考慮使用非處方藥物緩解疼痛，例如：乙醯胺酚 (英文學名：Acetaminophen，商品名稱：普拿疼)、 布洛芬 (英文學名: Ibuprofen，商品名稱：伊普芬) 等的非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs)。
外傷或肌肉拉傷的冰敷和熱敷：冰敷用於受傷後的前 48 小時，是將冰袋包裹毛巾後放在疼痛部位，每次 10-15 分鐘。熱敷：受傷 48 小時後可以考慮使用熱敷，但如果有尖銳疼痛或傷後腫脹，避免使用熱敷以免腫脹加劇，每次熱敷不超過 20 分鐘，切勿在睡覺時使用加熱墊以免燙傷。

什麼時候需要立即到急診尋求緊急幫助？
當您出現以下症狀時，立即至急診就醫：
您的疼痛變得劇烈，特別是突然發生腰部劇烈疼痛的情況。
疼痛劇烈並向背部或腹部擴散。

當您的腰部疼痛同時伴隨著呼吸困難或胸痛，。
嘔吐血液，或糞便中含有大量血液（超過 1 茶匙或 5 毫升）。
腹部變得非常硬或腫脹。
若發生以上情況請立即送急診。

出院回家後何時應返回急診評估?
發燒達 39°C 或以上，或出現寒顫。
出現嚴重脫水跡象，例如：超過 8 小時未排尿，感到非常頭暈或似乎要昏倒，感到虛弱像是要摔倒，疼痛加重、頻繁發作，或集中在腹部某個部位。
噁心或嘔吐無法緩解，難以進食或飲水。
解黑便或瀝青樣糞便。

何時應該至醫療院所就醫？
腰部疼痛持續 1 至 2 天未消失或未改善。
發燒達 38°C 或以上，或出現寒顫。
解尿時有疼痛感，或尿液中有血。
糞便中含有少量血液（少於 1 茶匙或 5 毫升）。
出現早期脫水跡象，例如：尿液顏色深，嘴巴乾燥，肌肉痙攣，全身虛弱無力，起身時感到頭暈。
出現新的或惡化的症狀。
若出現以上症狀請至醫療院所就醫評估治療及早處理潛在問題。

General weakness
虛弱衛教
什麼是虛弱？
虛弱通常指的是肌肉力量不足，並不同於感到疲倦或精神不濟。
虛弱可能由許多因素引起，有些是嚴重的問題，例如肌肉疾病或神經問題，也有一些較不嚴重的原因，比如過度使用肌肉，這也可能讓您感到虛弱。

如果醫生認為您的虛弱可能不是由嚴重的原因引起的，但他們可能無法在第一次診療時就找出所有引起虛弱的原因，最重要的是您要按時間回診持續追蹤。

我應該如何在家照顧自己？
避免酒精和非法藥物。
嘗試保持規律的身體活動，即使是輕度運動，如散步，也有助於您的健康。
每天嘗試待在戶外，陽光有助於提升您的心情和健康。
確保每晚至少有 8 小時的睡眠，嘗試每天在固定時間上床睡覺和起床。
保持健康均衡的飲食，包括蔬菜、水果、全穀類食物和低脂乳製品，這將有助於改善您的整體健康。
盡量避免在家中跌倒，如果您被建議使用拐杖或助行器，請按照使用說明來使用。

何時應該立即到急診就醫尋求緊急幫助？
如果您的虛弱並且有以下情況，請立即送急診：
出現中風的徵兆，如突發單側的臉部、手臂或腿部的麻木或無力，意識混亂或言語或理解困難，視力模糊或雙眼視力問題，頭暈、步態困難或走路偏一邊、失去平衡，無明顯原因的劇烈頭痛。
出現其他嚴重疾病的徵兆，或虛弱變得嚴重，如：發燒達 39˚C 或更高，或伴隨寒顫、出汗，走路或提物困難，或虛弱到無法下床，呼吸困難，或胸部不適，甚至意識變得無反應。

如果您感覺心跳異常快或慢，從躺著或坐著的姿勢站起來時感到頭暈或虛弱，請回急診評估處置。

虛弱何時應該就醫？
如果您的虛弱出現以下情況，可至醫療院所就醫看醫生:
您的虛弱加重，或出現新症狀，如語言不清或出現複視或重影。
您在進食或睡眠上有困難。
您在工作、家中或學校的表現變差。
您有新的或加重的症狀。

如果出現以上情況，可至醫療院所就醫看醫生。

Headache
頭痛衛教
我需要知道什麼？
若醫生認為您的頭痛可能不是由於嚴重問題引起的，您可以在家中休養恢復。

如果您有頭痛，如何在家中照顧自己？
您還應該：
服用非處方藥物來緩解疼痛，例如：乙醯胺酚（英文：Acetaminophen，商品名稱：普拿疼）、Ibuprofen (商品名稱：伊普芬)或其他非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs)。但如果您需要每天服用這些藥物來緩解頭痛，建議至醫院就診。
如果可以，請躺在安靜、昏暗的房間裡。
請按時吃飯，並避免跳過餐次。多喝水，儘量保證足夠的睡眠。
如果您經常頭痛或頭痛影響日常活動，可以記錄「頭痛日誌」，如此有助於您了解頭痛是否有規律。
請記錄以下頭痛特徵：
頭痛的位置（頭部或頸部）
何時頭痛，痛多久？
頭痛的感覺，例如鈍痛、尖銳、灼熱、刺痛或痙攣
可能引發頭痛的原因
使頭痛緩解或加重的因素為何？

頭痛何時應該尋求急診幫助？
如果您出現以下頭痛症狀請立即至急診就醫：
突然開始頭痛，並且迅速變得非常劇烈，或者可以形容為「一生中最嚴重的頭痛」。
出現癲癇發作或性格改變。
有中風的症狀：如突然發生臉部、手臂或腿部麻木或無力，特別是單側身體，意識混亂或言語理解困難，無論是單一眼睛，還是雙眼出現視力障礙或複視，走路困難、頭暈或失去平衡或協調，或是無明確原因的劇烈頭痛。
感到極度虛弱、困惑或嗜睡。
昏倒。
有頭痛並伴隨頸部疼痛、僵硬、發燒、寒顫、皮疹或嚴重的噁心嘔吐。
如果您出現以上頭痛症狀請立即至急診就醫。

若頭痛何時應該到醫院就診？
若出現以下症狀請到醫院看醫生
頭痛持續超過幾天，或者疼痛加劇或變得更頻繁

您經常或嚴重頭痛
您有新的頭痛，尤其是如果您懷孕或年齡超過 50 歲
您有新的或惡化的症狀
若有以上症狀，請至醫療院所就醫評估。

Hematemesis, Tarry stool, Bloody stool, GI bleed
吐血、解黑便、解血便，胃腸道出血衛教
什麼是胃腸道出血？
"胃腸消化系統"，或"胃腸道"是指人體內負責消化食物的所有器官，包括以下器官：
食道：將食物從口腔運送到胃的管道。
胃：消化和分解食物的主要器官。
小腸（也稱小腸道）：負責吸收營養。
大腸（也稱結腸或大腸道）：負責吸收水分並形成糞便。
胃腸道出血是指上述任何一個器官出現出血情況。有時候出血可能非常緩慢，您可能不會察覺，因為它發生在體內。另一些時候，可能會有明顯的症狀，例如吐血或糞便中帶血。

腸胃道出血出院後需要注意什麼？
如果醫生有幫您安排回診，請依照時間回診，若無法按時回診，請自行上網更改預約時間或聯絡客服電話。

如何在家照顧自己？
根據出血原因，醫生可能會要求您按指示服用藥物。
除非醫生允許，否則避免頻繁服用非類固醇消炎藥(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug, NSAIDs)，這些藥物可能會導致胃出血，常見 NSAIDs 包含阿斯匹靈(Aspirin)及布洛芬(Ibuprofen)等，如果需要經常服用這類藥物，醫生可能會開其他藥物來降低出血風險。
避免排便時用力過度。
記錄糞便中是否有血液或黑色、瀝青樣糞便的頻率，這可能是胃腸道出血的跡象。
避免飲酒，包括啤酒、葡萄酒和混合飲品。
如果您有便秘或排便時用力過度，可以嘗試以下方法：
多吃富含纖維的食物，如全穀物、水果和蔬菜。
每天多喝水和其他液體。
保持活動：每週大多數天嘗試步行、園藝或其他活動，每次至少 30 分鐘。
每天泡溫水澡：每次約 15 分鐘，一天兩次。
這些措施可以幫助緩解症狀，加快復原並減少進一步出血的風險。

何時應該立即就醫尋求緊急醫療幫助？
從直腸肛門出現大量血塊或鮮血。
出現嚴重的腹痛。
血便伴隨出現胸部不適、呼吸急促或頭暈。

出現以下情況請至醫院就醫：
出血量顯著增加。
嘔吐血液或像咖啡渣的物質。
糞便顏色變黑，或像瀝青樣便，或深紅，或有血跡。
排便頻率或硬度發生變化。
變得非常蒼白，或心跳持續加速。
感到非常虛弱，或站立時感到頭暈。
感到腹部疼痛或壓痛。
無意間出現體重減輕。
出現以上症狀請及時就醫，有助於防止症狀惡化並確保適當的治療。

Hematuria
血尿衛教
什麼是血尿？
尿液中有血，稱為「血尿（hematuria）」。

血尿可能的原因：
血尿可能由許多原因引起，包括嚴重的情況，如腎臟病變或腎臟、膀胱或前列腺癌。大多數情況下，尿液中的血是由較不嚴重的問題引起，例如膀胱或腎臟感染、腎結石、受傷或劇烈運動。有些藥物或食物也可能讓尿液看起來像有血。
若醫生認為您的血尿原因可能不是嚴重的問題，但可能無法在首次就診時就找到所有嚴重原因，因此，按時回診與後續追蹤是非常重要的。

如何在家照顧自己？
多喝水，除非醫生要求您限制水分攝取，否則請喝足夠的水，尤其是在炎熱天氣外出工作時，保持水分補充尤為重要。
定時上廁所，每 2 到 3 小時上一次廁所，儘量在有尿意時馬上去小便，避免憋尿。

什麼時候需要立即到急診尋求緊急幫助？
當您出現非常嚴重的背部、肩膀或腹部疼痛時，立即至急診就醫。

何時應該到醫療院所就診看醫生？
若出現以下症狀時，請您到醫療院所就醫評估：
發燒達到 38˚C 或以上，或有發冷症狀。
尿液混濁、有異味，或出現更多血液。
症狀在開始治療後 48 小時內未改善或變得更糟。
在完成治療後，血尿症狀再次出現。
出現新的或惡化的症狀。
若出現以上症狀請至醫療院所就醫評估治療，及早處理潛在問題。

Hemoptysis

咳血衛教

當您或您的孩子出現咳血的症狀，咳出血液或混有血液的黏液時，應即時就醫。如果您的孩子曾經被異物或食物噎到，即使是幾天或幾週前發生的，也應該告訴醫生。

如果您咳出大量血液，大約 1 杯或更多，或出現呼吸困難情況，請立即呼叫救護車送醫院。

Hiccups

打嗝衛教

什麼是打嗝？

打嗝發生在橫膈膜（分隔胸腔和腹腔的肌肉）突然收縮時。這時，空氣被快速吸入，聲帶閉合，從而產生特有的「嗝」聲。大多數打嗝，持續不到 48 小時，罕見的情況下， 打嗝可能持續更久，持續超過一個月的打嗝稱為「頑固性打嗝」。一般情況下， 打嗝會自行消失，但對某些人來說，打嗝可能持續很長時間，導致營養不良、疲勞或食慾減退。

如何在家自行緩解打嗝？

以下方法可以幫助緩解打嗝：

屏住呼吸，儘量屏住呼吸 5 到 10 秒。

閉嘴閉鼻呼氣，用閉合的嘴和鼻子呼氣，同時收緊腹部肌肉，感覺像在用力大便，保持這個動作 5 秒鐘。

刺激喉嚨，小口啜飲或漱冷水、咬一口檸檬，或者吞下一小撮白糖，這些刺激喉嚨咽部的方法可能有助於減緩打嗝。

坐姿調整，坐著時，將膝蓋拉到胸前並向前傾，儘量保持這個姿勢 30 秒到 1 分鐘。

什麼時候應該去看醫生？

如果打嗝持續超過 48 小時，應該去看醫生。醫師會詢問您的症狀並進行檢查。大多數打嗝情況是無害的，但根據您的症狀、病史和檢查結果，可能需要進行一些檢查以排除潛在問題。

Hypertension, High blood pressure, High blood pressure emergency

高血壓衛教

什麼是高血壓緊急情況？

高血壓緊急情況是一種相對嚴重的狀況，當血壓比正常值高出許多時發生。此時可能會對以下一個或多個器官造成損害：

眼睛：可能出現眼底出血或連接眼睛和大腦的視神經腫脹。

大腦：可能出現大腦腫脹、出血，或中風（由於血流問題造成腦部損傷）。

腎臟：可能導致腎衰竭（腎臟停止運作）。

心臟：可能出現心臟病發作、心衰竭，或血管損傷。

如不即時治療，這些問題最嚴重可能致命。

什麼是高血壓的緊急情況?

當發生「高血壓緊急狀態（hypertensive emergency）」時，血壓通常為「180/120」或更高，即收縮壓大於 180 mmHg 或舒張壓大於 120 mmHg，且造成器官的影響或受損，若高血壓造成器官的受損，醫生可能使用的其他醫學術語包括「惡性高血壓（malignant hypertension）」，有時當血壓非常高，但尚未對器官造成損害，這稱為「高血壓危機（hypertensive urgency）」，處理方式通常與高血壓緊急情況不同。

高血壓緊急情況的症狀是什麼？

症狀取決於受影響的器官，包括以下症狀：

視力模糊或其他視力改變，頭痛，噁心或嘔吐，意識混亂，昏迷或癲癇（癲癇是大腦中異常電活動的波動，可能導致人行為或動作異常），身體一側、手臂或腿部無力或麻木，說話困難，呼吸困難，胸痛，上背部或肩胛骨間的疼痛，棕色或帶血的尿液，下背部或身體一側的疼痛等等，以上是高血壓緊急情況的症狀。

可能需要做哪些檢查？

若您到急診室，會再次測量血壓，醫生會詢問您的症狀，根據您的症狀進行相關的身體評估與檢查。

如何治療高血壓緊急情況？

治療需要在醫院進行，醫生可能會給予快速降低血壓的藥物，同時，醫生也會治療因血壓過高引起的問題。

在家如何控制血壓:

大多數患者需要長期治療來控制血壓，包括：按規定服用藥物，遵守低鹽飲食，包含大量水果和蔬菜，減重（如果體重過重），定期運動等。

什麼時候應到醫院就醫？

如果您有前述「高血壓緊急情況」的症狀，尤其是合併高血壓，應立即到醫院就醫。

如果您在家使用血壓計測量血壓，發現兩次或兩次以上的讀數高於 180/120 ，兩次血壓量測間隔至少休息放鬆 30 分鐘，即使沒有其他症狀，也可以考慮至醫療院所評估治療。

Low back pain

下背痛衛教

對於下背痛的基本認識，我應該知道些什麼？

您可能有肌肉拉傷導致的下背痛，這是因為肌肉過度拉伸或過度工作所導致的，當肌肉拉伸過快時，也可能發生這種情況，這種情況也被稱為拉傷。

許多人在某個時候會經歷下背痛，但這通常會自行改善。

我應該如何在家中照顧自己？

可以考慮使用熱敷來緩解疼痛，每天幾次，每次將熱敷墊放在背部 20 分鐘，但切勿將熱敷墊放在背上過夜。

在不引起過多疼痛的情況下保持活動，可以讓下背休息一兩天，但白天要起身行走輕輕活動，幾天後如果您能忍受，逐漸增加活動量，如果某個動作讓您的疼痛加重或復發，請停止並回到之前不會引起疼痛的輕鬆活動。

保護您的背部，在疼痛完全消失之前，限制運動、扭轉動作和重物搬運。

不要長時間保持一個姿勢坐著或站著，您可以嘗試將枕頭放在膝下或膝蓋之間來幫助緩解疼痛。

可使用非處方藥物來緩解疼痛，例如布洛芬或萘普生。

何時應該尋求急診協助？

如果您有以下情況，請返回急診評估：無法走路，無法控制大便或小便(失禁)，發燒至 38˚C 或以上，或有寒顫或夜間出汗的情形。

如果您有以上症狀，請立即至急診評估治療。

如果您有以下情況，請至醫療院所就醫評估：

腿部麻木、無力或刺痛。

即使在服用藥物和休息的情況下，疼痛仍在加劇。

出現皮疹。

有新的或惡化的症狀。

如果您有以上情況，請至醫療院所就醫評估治療。

Migraine
偏頭痛衛教
什麼是偏頭痛？
偏頭痛是一種包含頭痛及其他症狀的疾病，可能影響成年人和兒童，女性更為常見。偏頭痛的頭痛，通常從輕微開始，然後逐漸加重。

成人偏頭痛的症狀有哪些？
偏頭痛症狀可能包括以下症狀：
頭痛，頭痛通常在數小時內加重，呈現搏動性，通常影響頭部的單側。
噁心，有時伴隨嘔吐
對光和噪音敏感，躺在安靜、黑暗的房間通常能幫助改善減緩症狀。
先兆(Aura)，有些人會在偏頭痛發作前或發作期間，會經歷稱為「先兆」的症狀或感覺，先兆症狀通常持續幾分鐘到一小時，多數人在 15 到 30 分鐘內消失。每個人的先兆不同，但多數影響視覺，例如:看見閃光、亮點或鋸齒狀線條，視力部分喪失，感到嘴唇、下臉部及一隻手的手指麻木和刺痛，聽到聲音或耳鳴。有先兆的偏頭痛患者通常不建議服用含雌激素的避孕藥，因為這可能增加中風風險。
許多人在偏頭痛發作前幾小時甚至一天會出現其他症狀，稱為「前驅症狀」("premonitory" or "prodromal" symptoms)，這些症狀可能包括打哈欠、感到沮喪、易怒、對食物渴望、便秘或頸部僵硬。

我需要做檢查嗎？
通常不需要。醫生會詢問您的情況評估後才決定相關檢查。

可以預防偏頭痛發作嗎？
可以，有些人發現某些情況會誘發偏頭痛，如果能避免這些情況，可能降低發作風險。

您可以記「頭痛日記」，記錄：
每次偏頭痛發作的時間
發作前的飲食和活動，看看是否有需要避免的食物或行為
使用的藥物及其效果

常見的偏頭痛誘因包括：壓力、荷爾蒙變化、跳過餐食或進食不足，天氣變化，睡眠過多或不足，明亮或閃爍的燈光，飲酒或吃某些食物，例如:乳酪或熱狗，吸煙或暴露於煙霧中，這些都是常見偏頭痛的誘發因素。

如果發作頻繁或嚴重，醫生可能建議學習放鬆技巧、管理壓力，或使用預防性

藥物，針對一些女性在月經前後容易偏頭痛也有藥物可以幫助。

如何治療偏頭痛發作？
醫生會幫助您找到合適的治療方法。
對於輕微偏頭痛，可以建議使用非處方藥緩解疼痛，例如：乙醯胺酚 (英文學名：Acetaminophen，商品名稱：普拿疼)、 布洛芬 (英文學名: Ibuprofen，商品名稱：伊普芬) 等的非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs)，或是結合乙醯胺酚、阿司匹林和咖啡因的藥物，例如：Excedrin。對於較嚴重的偏頭痛，有處方藥可用，例如:曲坦類藥物(triptans)，可緩解疼痛。有些處方藥可減少偏頭痛發作的頻率。如果伴隨嚴重的噁心或嘔吐，還有其他藥物可以緩解這些症狀。
不要自行頻繁使用非處方止痛藥治療偏頭痛，因為可能導致後續更頻繁的頭痛。
您可以做什麼來緩解？
您可以嘗試：在安靜、黑暗的房間休息，額頭放涼敷布，睡覺，請按照醫生建議服用藥物，避免使用未與醫生討論過的藥物。

如果有偏頭痛，想懷孕怎麼辦？
在準備懷孕前，請先與醫生討論，某些治療或預防偏頭痛的藥物在懷孕期間對於胎兒並不安全，因此可能需要提前更換藥物。有些人在懷孕和哺乳期間的偏頭痛症狀會有所改善，這與體內荷爾蒙變化有關。

什麼時候應該到醫療院所就醫？
如果您發生以下狀況請至醫院評估治療：
懷疑自己有偏頭痛發作，
偏頭痛發作加劇或更頻繁，
出現新的症狀。
若出現以上情形請至醫療院所就醫。

Myalgia, Arthralgia, Bone pain
肌肉、關節和骨骼疼痛衛教

什麼是肌肉、關節和骨骼疼痛？
這些是常見的症狀，但醫生有時很難確定疼痛的具體來源，這種疼痛也被稱為「肌肉骨骼疼痛」。
肌肉疼痛，比骨骼疼痛更常見，通常在使用肌肉時發生，休息後會有所緩解，疼痛也可能隨著活動會時好時壞。肌肉疼痛可能只出現在某一個區域，也可能遍及身體的較大部分，甚至整個身體。
關節疼痛，可以感受到在一個或多個骨頭交界關節的地方，疼痛可能會持續存在，或者只有在使用關節時才會感到。
骨骼疼痛，常常是在不使用該部位的情況下就能感覺到，這種疼痛通常感覺更深層，並且可能持續時間較長，骨骼疼痛時，可能較容易指向具體的疼痛區域。
有很多不同的因素可能引起這些類型的疼痛，例如:受傷可能會突然引發肌肉、關節或骨骼疼痛。關節炎等慢性病可能會引起隨著時間推移逐漸加劇的疼痛。許多不同的健康問題也可能會引起肌肉、關節或骨骼疼痛。

我應該如何在家照顧自己？
如何照顧自己會根據疼痛可能的原因來決定。
避免或停止引起疼痛的活動，某些類型的疼痛是由於反覆使用相同的肌肉或關節所引起的，您可能需要停止或限制這些活動，以便讓身體休息和恢復。
使用非處方藥來緩解疼痛，口服止痛藥物，例如: 乙醯胺酚（學名: Acetaminophen，商品名：普拿疼）、布洛芬 (學名:Ibuprofen)，有些藥物是以乳膏或凝膠的形式塗抹在皮膚上的。
使用夾板、護具或彈性繃帶來讓受傷部位休息和康復。
使用冰敷或熱敷來緩解疼痛：冰敷:每 1 到 2 小時用毛巾將冷凝膠包或冰袋包裹，敷在疼痛部位，每次敷 15 分鐘；熱敷:若是疼痛部位無腫脹，可以將熱敷放在疼痛部位，每次約 20 分鐘，每天幾次，切勿在睡覺時使用加熱墊，因為這可能會引起燙傷。
做伸展和強化肌肉及關節的運動。
醫生也可能建議改善姿勢和運動方式，這有助於減少對肌肉、關節和骨骼的壓力和拉傷。

我需要哪些後續照護？
按照約診的時間回診。

肌肉、關節和骨骼疼痛，什麼時候應該到醫療院所就醫？

若肌肉、關節和骨骼疼痛合併出現以下症狀請至醫院看醫生:
發燒達到 38°C 或更高，或有寒顫。
非處方藥物無法緩解疼痛。
在進行日常活動時遇到困難。
兩週後仍然有疼痛。
尿液明顯變少。
若肌肉、關節和骨骼疼痛出現以上症狀請至醫療院所評估處置。

Nausea and Vomiting
噁心嘔吐衛教

當您的嘔吐症狀合併出現以下情況時，請及時尋求醫療協助：
嘔吐症狀持續超過 1 至 2 天，或症狀嚴重。
伴隨有胸痛或腹痛。
嘔吐物中有血，或嘔吐物看起來像咖啡渣。
排便時帶血，或排出黑色、像瀝青的糞便。
發燒超過 38°C。
有嚴重的頭痛或頸部僵硬。
感到極度疲憊或無法起床。
出現脫水跡象，即身體失去過多水分，例如：感到非常疲倦，極度口渴，或口腔和舌頭乾燥，肌肉痙攣，頭暈即將失去意識，意識模糊，尿液顏色深黃，或超過 8 小時沒有排尿。
以上這些症狀可能表明潛在的健康問題，需要及時醫療評估和處理。

在家如何照顧自己？
補充液體，每 15 到 30 分鐘飲用少量液體。適合的飲品包括水、肉湯和口服電解質溶液，也可以飲用無糖或低糖的運動飲料。
逐步恢復飲食，開始時選擇含水分多的食物，例如湯、果凍(明膠 Gelatin)和冰棒。
如果能耐受，嘗試柔軟、清淡的食物，例如麵包或蘇打餅乾，這些富含碳水化合物的食物能幫助舒緩胃部不適感。
少量多餐，避免一次進食過多。
避免油膩食物，避免刺激性飲料，例如酒精和咖啡因，這些飲品可能會加重脫水或刺激胃部。
糖尿病患者的特殊注意事項，如果您有糖尿病，生病可能會影響血糖濃度，應該要比平時更頻繁地量測血糖。
勤洗手，經常洗手以防止將可能的病毒傳染給他人。

Palpitation

心悸衛教

心悸定義，為患者察覺到心臟用力、快速或不規則跳動。患者可能將這種感覺描述為胸口快速的顫動、翻滾，或者胸部或頸部的悸動感。

當您的感到心悸且出現以下任一情況時，請立即尋求醫療協助：

如果您感到頭暈或即將昏厥。

如果您出現冒冷汗，皮膚濕冷出現大理石斑。

如果您出現低血壓。

身體休息靜止時，心跳超過 120 下。

如果您有呼吸急促、呼吸困難。

如果您出現胸痛症狀。

如果您注意到心跳出現新的變化。

如果您有其他讓您擔憂的新症狀。

若檢查一切正常，大多數情況下，心悸不需要藥物治療，而有什麼可以在家自己做的嗎？

您可以採取以下措施：

按照醫囑指示服用藥物。

避免吸煙。如果戒菸有困難，可以尋求戒菸門診協助。

避免或者減少使用酒精和咖啡因飲品。

嘗試進行規律適量的運動，即使是輕度活動，如步行，對健康也有益。如果運動引發心悸或其他症狀，請與醫生討論哪些運動是安全的。

睡眠充足，每晚嘗試睡眠 6 到 8 小時。

找到健康的方式來應對生活壓力。

這些措施可以幫助改善您的整體健康並減少心悸的發生。

Seizure
癲癇衛教
什麼是癲癇？
癲癇發作是由大腦異常放電所引起的。可能會讓人發生抽搐、意識不清、昏倒，或是出現異常的動作或行為，癲癇可以發生在任何年齡。

癲癇發作的症狀有什麼？
癲癇發作有不同種類，每種類型會引起不同的症狀。大部分癲癇發作只會持續幾秒鐘或幾分鐘。
患有「強直-陣攣性」或「大發作」的人，會突然無意識昏倒、全身僵硬，接著出現抽搐的動作。其他類型的癲癇發作症狀則較不明顯，例如有些人只會在一隻手臂或臉部的一部分出現抽動的動作，有些人則會突然停止反應，盯著某個地方看幾秒鐘。
有時候，當病患知道自己快要發作了，他們會有某種感覺，或者聞到某種氣味，這種感覺或氣味被稱為「先兆」。

如何降低發作癲癇的機會？
您應該按照醫囑準確服用藥物，確保充足的睡眠，睡眠不足會增加發作癲癇的機會，避免飲酒和吸毒。

如果我患有癲癇，可以開車嗎？
不建議開車，除非得到醫生的許可。

如果患有癲癇，有哪些注意事項、還應該做些什麼？
您應該：
可考慮戴上醫療手環，讓他人知道您有癲癇。
告訴家人和朋友如何幫助您應對癲癇發作，他們可以幫您調整姿勢，避免您受傷，並告知他們不應該把任何東西放入您口中，此外，請他們計算癲癇持續發作的時間，若癲癇發作超過 5 分鐘時請叫救護車將病患送醫。

與醫生討論如何在家中保持安全，他們會建議一些方法來降低癲癇發作時受傷的機會：
例如，可以將家中的地毯鋪設為牆到牆的軟地板，這樣跌倒時，地板比較柔軟不易受傷。
洗澡時改為淋浴而非泡澡，並使用淋浴椅。
在進行可能危險的活動時（例如游泳或使用電動工具），最好有他人在旁陪伴。
改變一些生活習慣和日常作息，以降低自己或他人受傷的風險。
以上幾點可以降低癲癇發作時受傷的風險。

癲癇病患何時應該就醫評估治療？

一般來說，如果您比平常更頻繁地發作或癲癇發作的時間比平常更長，應該聯繫您的醫生或護士。

有些癲癇發作是醫療緊急情況。如果您發作超過 5 分鐘，或發作次數達到 2 次以上而中間沒有清醒，陪伴您的人應該呼叫救護車。

如果出現以下情況，請至醫院評估：

癲癇發作開始變得更頻繁。

癲癇發作變得更嚴重。

您的思維或情緒發生變化，例如感到沮喪或焦慮。

其他人注意到您的行為變得不尋常。

您有新的或更嚴重的無力，特別是出現在身體單側。

您有新的或更明顯的平衡問題。

您的藥物有副作用。

如果出現以上情況，請至醫院評估。

Shock

休克衛教

什麼是休克 (Shock)?

休克是一種當血壓過低，導致身體器官和組織得不到足夠血液和氧氣的情況。最常見的休克原因是大出血，例如在事故或受傷後。但休克也可能發生於其他情況，例如嚴重感染、過敏反應或心臟問題。

休克是一種危及生命的狀況，處於休克中的人需要立即治療，否則體內器官將停止運作，最終導致死亡。

休克的症狀是什麼？

症狀取決於休克的原因及其嚴重程度，主要症狀包括：

低血壓，如果測量脈搏，可能感到微弱。

心跳加快，

行為異常，包括：意識模糊，患者可能無法集中注意力，或者不知道自己身在何處。

對他人說話沒有反應，

皮膚變得冷、濕黏，顏色可能是灰藍色，或者泛紅發熱。

排尿減少，明顯少於平常。

休克是否應該就醫看醫生？是的，越快越好。

有以下情況應立即請前往最近的急診室就醫：

如果您不在醫院，有受傷或感染以及前述任一項休克症狀，

最近接受過手術或住院，現在感到不適或有感染跡象以及前述任一項休克症狀。

如有以上情況應立即請前往最近的急診室，如果您有嚴重受傷，例如骨折或出血傷口，請立即撥打 119 叫救護車。

休克是一種危險的緊急狀況，及時治療對於患者的生存至關重要。

Shortness of Breath, SOB, Dyspnea

當您的呼吸急促或呼吸困難出現以下情況時，請立即尋求醫療協助：

呼吸急促，且懷疑自己正在經歷心臟病發作。

呼吸急促，且伴隨新發生的胸痛。

嚴重呼吸困難，即使靜止不動也難以呼吸。

因過敏反應引起的呼吸急促。

如果您之前已因呼吸急促就診，而此次呼吸急促情況惡化時。

Skin rash

皮膚疹子(皮疹)衛教

什麼是皮疹？我應該知道什麼？

許多物質可能會刺激皮膚並引起皮疹，如植物、肥皂以及某些金屬，皮疹也可能是某些藥物的副作用，醫生可能無法確定引起您皮疹的具體原因。

我應該如何在家照顧自己？

使用不含香料的乳霜或潤膚乳來保持皮膚濕潤。

多喝水，保持身體水分。

洗澡時使用冷水或溫水，不要使用熱水，用乾淨、厚實、柔軟的毛巾輕壓皮膚擦乾，使用溫和且不含香料的肥皂、潤膚霜和除臭劑。

以下緩解癢感的方法：

保持指甲短且乾淨。

如果您在睡覺時會抓癢，可以戴上棉製手套。

可以使用冷敷來皮膚感覺舒適搔癢感緩解，將乾淨的毛巾浸入冷水中，然後敷在皮膚上。

以上是舒緩皮膚搔癢的方法。

如果您知道引起皮疹的原因，請避免再次接觸。如果是藥物引起的皮疹，請與您的醫生討論，看看是否可以更換藥物。

什麼時候需要緊急就醫？

如果皮疹合併出現嚴重的呼吸或吞嚥困難，或者無法完整說出句子，請立即到急診尋求緊急醫療幫助。

如果出現以下情況，請您回到急診評估治療：

皮疹惡化或擴散至身體大範圍區域。

雖然可以說完整句子，但您仍然有呼吸困難。

什麼時候應該到醫療院所就醫看醫生？

如果您有以下症狀，請您到醫療院所就醫：

發燒 38˚C 以上或寒顫

感染的徵兆，例如腫脹、發熱、疼痛或皮疹處有分泌物

新出現或加重的症狀

Syncope
暈厥、暈倒衛教

當我有發生暈倒的狀況，是否應該就醫檢查治療？
是的，任何暈倒的人都應該去看醫生就醫。大多數暈厥的情況並不嚴重，但暈倒時可能會受傷，但有些情況下，暈厥是由嚴重的疾病引起的，應該接受治療，就醫了解引發你暈倒的原因，有助於預防再次發生。
請告訴醫生或護士你暈倒前、暈倒中和暈倒後的情況，如果當時有其他人在場，請他們可能能告訴你發生了什麼事，而以下的訊息對於了解暈厥的原因會有所幫助：
你有暈倒的病史嗎？
你暈倒前在做什麼？
你暈倒前有什麼樣的感覺？
你暈倒了多久，無反應或無意識持續多久？
失去意識時，是否伴隨著手腳抽蓄，眼睛上吊，口吐白沫，發紺或臉色蒼白的症狀？
你恢復得怎麼樣？別人叫醒你時，即能了解別人的語意，做出正確的回應，例如能夠說得出自己名字，遵從他人指令，還是要等至少 10 分鐘以上才能比較清醒，才能對於周遭環境的刺激予以反應。
你有的任何疾病。
你正在服用的藥物清單。
以上的訊息對於了解暈厥的原因會有所幫助。

昏厥的原因是什麼？

昏厥發生在大腦暫時無法獲得足夠的血液時，最常見的原因叫做「反射性」或「迷走神經性」昏厥，如果您有反射性昏厥，您的身體會出現心跳過慢或血管擴張，或兩者都有，這種情況可能由多種不同因素引起，以下情況可能出現反射性昏厥：
因為恐懼或疼痛而感到壓力（例如，受傷或抽血檢查）
站立太久或過度疲勞或過熱
對排尿、咳嗽或其他身體功能有異常反應
有時候反射性昏厥會在沒有明確原因的情況下發生。

人們也可能會出現非反射性昏厥，這可能是由以下問題引起的：
因為心臟的電氣系統問題或某些藥物的副作用，心臟跳動過快或過慢。
心臟內部有東西阻塞了血液流動，這種情況可能發生在患有「主動脈瓣狹窄」或「肥厚性心肌病變」的人身上。

當您站立或坐起時，血壓下降，這種情況可能有以下原因：
沒有喝足夠的水
服用了某些會導致血壓下降的藥物
喝了過多的酒精
失血過多（例如，受傷時）
有影響血壓的健康狀況。

昏厥能預防嗎？
如果您了解昏厥的原因，您可能可以減少再次昏厥的機會。
如果某種活動或某些情況會引發您的昏厥，您可以嘗試避免這些情況。
如果是藥物引起昏厥，您的醫生可以幫助您尋找替代藥物。
如果是心臟問題引起昏厥，您的醫生可以建議您進行治療。
當您感覺可能會昏厥時，請躺下並將雙腳墊高。
以上皆有助於減少暈厥的風險。

如果我的孩子昏厥怎麼辦？
如果您的孩子昏厥，應該帶他們去看醫生。

大多數兒童昏厥的情況並不嚴重，通常是由反射性昏厥引起的。
兒童發生昏厥的原因還包括：
他們憋氣時間過長。
當他們站立或坐起來時，姿勢性的低血壓，血壓下降。
他們吞服了藥物、毒品或酒精。
他們有一氧化碳中毒。
在較不常見的情況下，兒童的昏厥可能是由生命危險的狀況引起的，例如嚴重的心臟病、過熱或嚴重的過敏反應導致過敏性休克。
以上為可能兒童發生暈厥之原因，如果您的孩子發生昏厥，應該帶他們去醫院就診。

Trauma, contusion, sprain
一般外傷、鈍挫傷、扭傷、拉傷衛教

創傷後 48 小時內,患處可使用冷敷,但不可將冰塊直接置於皮膚上,需用毛巾或手帕墊於患處,48 小時後再熱敷。
患肢於彈性繃帶固定時,如有太緊 (患肢末端冰冷,麻木或膚色變紫) 或太鬆,應重新綁過。
患處若有傷口,需經常換藥以保持清潔與乾燥為原則。
請於 2~3 天後到相關門診追蹤。
上肢可以使用三角巾撐托。

外傷若有以下情形,請盡早回醫院就診：
受傷的地方有腫脹合併肢體末端冰冷、麻木、劇烈疼痛。
受傷處有紅、腫、熱、痛、甚至發燒的情形。
患處有變形。
5 ~ 7 天後扭傷或拉傷仍未改善。
外傷若有以上情形,請盡早回醫院就診。

鈍挫傷須知
隱藏性骨折
當骨頭受到衝擊時,若骨折處很小或骨折線很細,衝擊面的骨頭沒有位移,最初的 X 光會顯示正常,我們稱為「隱藏性骨折」,發生率為 7 ~ 45 %,通常經過身體的活動後,於數日甚至數周後,再追蹤 X 光片,才可較清楚的看見骨折處。

潛在性神經、肌肉、韌帶損傷
關節由肌肉、神經、韌帶、血管組成,當關節受傷,這些附屬組織都會受到影響,但在關節腫脹時期,這些傷害難以檢視,通常在受傷數日後,關節腫脹較緩解,再進一步做相關檢查。

遲發性內出血
當軀幹受到撞擊,有些微血管滲血 (非動脈、靜脈出血) 不易在當下馬上發現,可能數小時或數天後才逐漸表現出症狀,故臨床上可見延遲性的血胸、腹內出血、後腹腔出血等,故需隨時注意相關的症狀。

鈍挫傷若有下列情形之一,請盡早回本院診治：
挫傷處持續並嚴重的疼痛。
持續的關節腫脹、持續的關節活動度受限。
腹脹腹痛、背痛、腰痛等症狀加劇。

呼吸困難、胸悶、臉色蒼白、冒冷汗、姿態性暈眩。
鈍挫傷若有以上情形,請盡早回本院診治。

若病情穩定,也請您於受傷後 3 日內回按時間回門診追蹤。

Trauma, suture wound, abrasion wound
傷口處置原則，擦傷、撕裂傷，縫合傷口衛教

經過醫院傷口處置及衛教後，相信您已學會傷口自我照護，為了讓您在家能更正確執行傷口自我照護，建議您準備下列用品：
生理食鹽水 500c.c. 1~2 罐、無菌口腔棉棒數包、無菌紗布：2x2 吋或 3x3 吋數包、透氣紙膠 1 捲、人工皮。
居家簡易傷口，正確的更換敷料步驟如下：
1. 換藥前需先洗手。
2. 撕下舊紗布(沾黏時先用生理食鹽水潤濕)。
3. 觀察傷口的變化:大小改變?分泌物的多少及性質?顏色的變化?是否有異味並記錄下來，建議每天換藥 2 次，若傷口有浸濕可增加換藥頻率，可以洗澡完換藥一次，隔 12 小時再換藥一次，洗澡時儘量避免傷口沾濕。
4. 以棉棒沾食鹽水,從傷口的中央由內往外環形塗擦,至傷口清潔;棉棒僅可使用一次,之後再用醫師開立的藥膏塗擦傷口，避免擦拭優碘及可能造成色素沉著之抗生素藥膏。
5. 蓋上紗布貼上透氣膠帶。
6. 換藥後洗手。

傷口換藥注意事項如下：
傷口縫合後，請保持傷口乾燥，避免浸泡水中。
傷口上的紗布如果不慎弄濕，請儘速除去紗布，以無菌棉棒沾生理食鹽水由內往外環狀擦拭傷口，再塗抹醫師開立之藥膏後覆蓋上無菌紗布。如果不會自行換藥，請預約回門診換藥。
如果傷口較大或較為複雜的傷口，請聽從醫師的指示返院換藥。
密切注意傷口處有無再出血情形。如傷口在關節處，應保持關節平直，避免活動時牽扯縫線，造成傷口裂開再度出血。
受傷後 8 ~ 12 小時組織會持續腫脹，請抬高受傷部位以減低腫脹程度。
請按照醫師指示服藥，並避免傷口感染。
勿在傷口處塗抹任何未經醫師許可的藥膏以免發炎。
避免吃刺激性的食物，如菸、酒、辣椒等。
多攝取高蛋白 (如：肉、蛋、奶、魚類)、高維生素 C(如：奇異果、柳橙)的食物，可促進傷口癒合。
避免傷口劇烈運動，以防傷口裂開。

如果有下列情形，請盡早返院接受進一步評估處置：
傷口於 3 ~ 4 天為高感染時期，若出現發燒、寒顫，傷口出現紅腫熱痛，傷口有非透明或混濁分泌物滲出，若有這些情形請盡早回診。

縫合傷口拆線時間因受傷部位不同而有差別，需按照醫師預約的門診回診評估傷口是否適合拆線，由醫師協助拆線，有時候，急診醫師會視傷口嚴重程度，安排提早回診評估傷口復原狀況。

如何預防疤痕產生，建議如下：
傷口拆線後可以立即使用美容膠，與傷口採垂直方式貼，最少要連續使用 3 個月，不需每天更換。
縫合後第 10 天可以在乾淨無滲液的傷口部位，貼上防疤產品避免疤痕產生。
每天用手指頭輕輕按摩傷口 2~6 分鐘， 一天多次。
易過敏、害怕或易產生疤痕的體質，則可按個人喜好，使用各種預防疤痕產生的產品，如美容膠、除疤凝膠、矽膠片，但這皆屬於輔助品，仍需要依據個人體質以及疤痕生成的部位而定。
無論使用任何防疤產品，都建議使用 3~6 個月。
避免陽光直接曝曬傷口，使疤痕顏色加深。

Upper back pain
上背痛衛教
什麼是上背痛？
上背痛是指從頸部底部到背部中間的疼痛，這部分稱為「胸椎」(thoracic spine)。胸椎的兩側有肋骨連接的部位，上背部和肋骨幫助穩定背部，並保護胸腔內的器官，相比於頸部或下背部，上背部的活動範圍較小。
如果出現上背痛，您可能也會感到頸部、手臂和肩膀疼痛。

背部的構造是什麼？
背部由以下部分組成：
脊椎骨，脊椎的骨骼，每塊椎骨中央有一個孔，脊椎骨堆疊組成一個稱為「脊髓管」的中空管道，脊髓穿過此管並受到椎骨保護。脊髓是將大腦與身體其他器官連接的神經束，負責傳遞訊號，可將大腦發出的神經訊號，往下傳遞給周邊神經，進而連接到手臂、腿部或器官。椎間盤，橡膠狀的椎間盤軟骨位於每塊椎骨之間，為脊椎提供緩衝並允許活動。肌肉、肌腱和韌帶，這些結構支持椎骨，幫助移動頭頸、保持直立以及彎曲和伸展身體，統稱為頸部和背部的「軟組織」。

上背痛的原因是什麼？
許多因素都可能導致上背痛，大多數情況下，醫生無法給您一個確定具體的原因。上背痛可能是由於肌肉拉傷引起的，有時候，劇烈活動後會突然出現疼痛，例如投擲、搬重物、扭轉或彎腰後可能出現疼痛，其他可能導致上背痛的原因包括：不良姿勢，椎間盤損壞、膨出或撕裂，脊椎關節的關節炎，椎骨上的骨質增生壓迫鄰近神經，椎骨或肋骨移位，脊髓管變窄，意外或受傷，上腹部或胸腔器官的問題，感染或腫瘤(少見)。

如何診斷上背痛？
醫生進行檢查，詢問您的健康史，包括既往病史、手術史以及正在服用的藥物，他們會觀察您的活動與彎曲能力，並可能檢查您的肌肉力量和反射，大多數人不需要進行進階的影像檢查，例如 CT 或 MRI，大多數情況下，上背痛會在幾週內自行緩解，除非有異常跡象，否則醫生不一定會安排影像檢查，如果醫生沒有安排影像檢查，請不要擔心，他們僅需透過與您交談與身體評估就可以決定要做那些檢查與處置。

上背痛如何在家治療？
大多數上背痛患者沒有嚴重的健康問題，您可以嘗試以下簡單的治療方法：
保持活動，嘗試在不加重疼痛的情況下盡量保持活動，對於輕微背痛的患者，如果能保持活動並避免臥床休息，恢復速度會更快；如果疼痛很嚴重，可以選

擇休息一兩天，但儘快恢復步行和活動很重要；疼痛期間應避免搬重物、扭轉、伸手和運動，但可以繼續進行日常活動。
熱敷，不適用於急性外傷或扭傷之病人，可考慮在急性期後 24-48 小時再開始熱敷，對於某些病人使用加熱墊或熱敷包，短時間內將有助於緩解疼痛，可以考慮每天幾次將加熱墊（低溫設置）放在上背部，每次 20 分鐘，但注意避免高溫以防止燒傷。
藥物，如果需要，可以服用非處方藥物來緩解疼痛，例如：乙醯胺酚（英文：Acetaminophen，商品名稱：普拿疼）、Ibuprofen (商品名稱：伊普芬)或其他非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs)
其他緩解症狀的治療，一些治療可能幫助您短時間感覺更好，例如以下幾種方式：
脊椎調整，專業人士（如脊椎按摩師或物理治療師）對背部關節進行調整。如果您想嘗試這種方法，請先與醫生討論。
針灸，通過在身體上插入小針來阻止疼痛信號的傳遞。
按摩，按摩師會針對背部的肌肉和其他軟組織進行按摩。
物理治療，在某些情況下，醫生可能建議學習特定的運動或伸展操來幫助緩解疼痛。

如何預防上背痛？
保持活動並伸展肌肉很重要，其他預防上背痛的建議包括：使用良好的姿勢，避免長時間維持同一姿勢站立或坐著，避免背過重的背包或包包，如果在辦公室工作，請確保電腦處於眼睛高度，並使用具支撐性椅子，如果穿戴胸罩，確保有良好的支撐效果，睡覺時使用具支撐性的枕頭，避免趴著睡覺。

什麼時候需要立即到急診尋求緊急幫助？
當您的上背疼痛出現以下症狀時，立即至急診就醫：
您有呼吸困難，
您的疼痛變得嚴重，
您的手臂出現新的無力或無法移動，
若您發生以上情況應該立即到急診就醫評估治療。

若出現以下症狀時，請您到醫療院所就醫評估：
手臂麻木、無力或刺痛，
您有 38˚C 或以上的發燒、寒顫，或咳出綠色或黃色的痰，
儘管服用藥物和休息，但疼痛仍然加重，
因為疼痛無法完成日常活動或睡眠困難，
若出現以上症狀請至醫療院所就醫評估治療，及早處理潛在問題。

Urinary retention
尿滯留衛教
什麼是尿滯留？
尿滯留是指您在排尿時遇到困難，您也許可以排出一些尿液，但無法完全排空膀胱，或者是您根本無法排尿。
尿滯留是由於尿路或控制尿路的神經出現問題所引起的。
尿路是人體中負責製造和儲存尿液的器官系統，包括：
腎臟，這是兩個豆形器官，負責過濾血液並製造尿液。
輸尿管，這是兩條將尿液從腎臟運送到膀胱的管道。
膀胱，這是儲存尿液的氣球狀器官。
尿道，這是將尿液從膀胱排出到體外的管道。

尿滯留可以是急性或慢性的，急性尿滯留發生得很突然，並需要立刻治療。
尿滯留有哪些症狀？
急性尿滯留和慢性尿滯留的症狀略有不同。
急性尿滯留，是指您突然無法排尿，症狀可能包括：
無法排尿，即使您有強烈的排尿衝動，也可能有下腹疼痛或不適，由於膀胱充滿尿液，對周圍器官施加壓力，導致疼痛或不適，這種疼痛或不適可能會很嚴重。急性尿滯留是急症，如果您認為自己有急性尿滯留，應該立即就醫。
慢性尿滯留，是指隨著時間的推移，您越來越難以排尿，症狀可能包括以下幾點：
雖然能排出一些尿液，但排尿後仍覺得膀胱未排空。
沒有強烈的排尿衝動。
排尿流速緩慢或不規則。
難以開始排尿，例如需要費力或用力推肚子才能讓尿液排出。
上述皆是慢性尿滯留的可能症狀。

尿滯留的原因是什麼？
尿液流動受阻：可能為腎結石、膀胱結石，或攝護腺肥大壓迫尿道所造成。骨盆底脫垂也可能造成排尿受阻，當骨盆底的肌肉無法有效支撐骨盆內的器官時（例如膀胱、子宮、直腸等），這些器官會脫垂且進入它們不應該處於的空間。此外，尿道過窄，尿道周圍肌肉張力過大，泌尿道或腹部癌症也可能造成排尿受阻。
膀胱肌肉問題，包括膀胱肌肉張力差或控制膀胱肌肉的神經受損。
其他骨盆底肌肉問題
某些麻醉或手術
某些藥物，例如，治療癲癇、高血壓或過敏的藥物可能會引起尿滯留。
感染

骨盆、尿道或陰莖受傷
便秘
分娩

尿滯留需要做檢查嗎？
是的，醫生會詢問您的症狀並進行檢查，也會進行一些測試。

檢查急性尿滯留的方法可能包括：
膀胱超聲檢查 ，這是一種影像檢查，可以產生體內結構的圖片，超音波檢查可以顯示膀胱是否已經充滿。
插入導尿管，導尿管是一條細而柔軟的管子，它可以通過尿道插入膀胱，幫助膀胱排空。醫療人員會測量膀胱內的尿量，判斷膀胱是否滿。

檢查慢性尿滯留的方法可能包括：
排尿後殘尿量（postvoided residual, PVR）測試，您先排尿，然後醫療人員會測量膀胱內剩餘的尿液量，可以通過超音波或插入導尿管來測量餘尿量，這個檢查可能要重複幾次，您可能還需要其他檢查來找出引起尿滯留的原因。

尿滯留如何治療？
治療包括排空膀胱和處理引起尿滯留的根本問題。
為了排空膀胱，會插入導尿管，有不同類型的導尿管可以使用：
長期留置導尿管，這是將一條細管插入尿道後留在體內的，尿液會從膀胱排出，經導尿管流入收集袋。
間歇性導尿管，這種導尿管在膀胱需要排空時才使用，導出尿液後，導尿管會取出並丟棄，當膀胱需要再次排尿時，會使用新的導尿管，如果需要的話，醫生或護理師可以教您如何使用這種導尿管，這種導尿管比長期留置導尿管更不容易引起尿道感染。
恥骨上導尿管，這種導尿管需要手術放置，通常只有當其他類型的導尿管無法使用時才會使用，醫生會將導尿管從尺骨上方、肚臍下方插入膀胱排出尿液。
有些人只需要短期使用導尿管，但有些人需要長期使用。

其他治療取決於引起尿滯留的原因，包括以下幾項：
骨盆底肌肉訓練，這包括學習鍛鍊和放鬆骨盆肌肉的運動，其中包括控制排尿和排便的肌肉。
停止或改變您正在服用的藥物。
服用新藥。

陰道托器，這是一種治療骨盆器官脫垂的裝置，放置在陰道內以支撐膀胱並將其推回原位，托器有不同的形狀和尺寸，醫生會和您討論，以確保陰道托適合您的身體。
膀胱訓練，這是指您在白天按計劃的時間來排尿，並盡量等到指定時間再排尿。
手術，如果其他治療方法無效，通常只有在必要的時候才會進行手術。

Vaginal bleeding in early pregnancy
懷孕早期陰道出血衛教

您應該知道的基本概念:
您來急診室（ER）是因為早期懷孕出現陰道出血，這可能讓人感到擔心，但大多數情況下，出血會自行停止，懷孕能正常持續。如果懷孕在 20 週前結束，則稱為妊娠喪失或「流產」。正常懷孕大約持續 38-40 週。

您若懷孕早期陰道出血，可能還會感到腹痛或痙攣。

若遇到懷孕早期陰道出血如何在家中照顧自己？
請詢問醫生或護士您在回家後應該做什麼或不應該做什麼，請確保您完全了解需要做的居家照方式，如有任何不明白的地方，請提問。
若您從急診出院回家，請提早回診或依照急診安排回婦產科門診的時間回診，回診時請告訴他們您去過急診，並由婦產科醫師安排後續檢查。
在疼痛和出血停止之前，醫生可能會建議您：
避免搬重物。
避免使用沖洗劑和衛生棉條。
避免性生活。
避免跑步和其他運動。
多喝水以保持身體水分充足。
請遵從醫生告知您的出院照顧指示。

懷孕早期陰道出血何時應該要緊急就醫掛急診？
當您出現以下症狀時，應立即至急診就醫：
出血量多到每小時浸透 1 片衛生棉，持續 2 小時或更久。
出血多到讓您感到非常虛弱或似乎要暈倒。
有感染跡象，例如：發燒 38˚C 以上，發冷，嚴重的腹痛或陰道疼痛，陰道分泌物有異味。
若您發生懷孕早期陰道出血合併以上情況請立即掛急診。

懷孕早期陰道出血應該何時到醫療院所就醫看醫生？
若您有懷孕出現以下症狀時，請您到醫療院所就醫評估：
發燒 38˚C 以上，但沒有其他症狀。
陰道分泌物看起來像膿或呈綠色。
陰道出血加重。
排出粉紅色或灰色的固體組織。
疼痛沒有改善。

感到非常悲傷、焦慮或沮喪。
出現新的或加重的症狀。
若出現懷孕早期陰道出血合併以上症狀請至醫療院所就醫評估治療，及早處理潛在問題。

Vaginal bleeding in late pregnancy
懷孕後期陰道出血衛教

陰道出血在早期懷孕很常見，而 20 週之後的懷孕出血則比較少見。
懷孕後期陰道出血的可能原因包括：
胎盤問題：胎盤早期剝離，胎盤在分娩前從子宮壁分離。前置胎盤：胎盤覆蓋子宮頸開口。子宮破裂：過去手術（如剖腹產）的疤痕處可能有撕裂的狀況。
陰道或子宮頸問題：如割傷、擦傷、增生物、疣或感染。
子宮頸機能不全：子宮頸在無分娩徵兆的情況下提前打開，正常情況下，子宮頸應在分娩開始時才打開。
分娩開始：出血可能表示即將分娩，如果 37 週之前發生，稱為早產分娩。
臍帶血管問題（臍帶血管前置）：前置血管是一種罕見但嚴重的妊娠併發症，指未受保護的胎兒血管穿越或靠近子宮頸口，這些血管未被胎盤或臍帶支撐，容易在分娩過程中破裂。
不明原因：有時出血原因不明。
以上是懷孕後期陰道出血可能原因。

懷孕後期陰道出血是否需要看醫生？
是的。如果懷孕期間出現陰道出血，請立即聯繫您的產檢醫生、醫院或診所。他們會詢問您的情況並告訴您是否需要去醫院或診所。
如果您無法聯繫醫生，或出血量很大以致衣服被浸濕，請前往急診室。若出血非常嚴重，請打 119 叫救護車。

懷孕晚期陰道出血的治療方法
治療取決於原因、出血程度和懷孕進展。例如：
胎盤問題：可能需要住院接受密切監測。
健康危險：如果母體或胎兒健康受威脅，可能需要盡快進行剖腹產。
陰道或子宮頸問題：可能需要針對割傷、感染等進行治療。
子宮頸機能不全：醫生可能會用縫合術（宮頸環紮術）幫助保持子宮頸閉合。
早產分娩：可能需要藥物減緩分娩進程，根據孕期也可能給予其他藥物。
母親 Rh 陰性血型：需要注射「抗 D 免疫球蛋白」（如 RhoGAM），以防止母嬰血型不合問題。
大量失血：可能需要靜脈輸液，嚴重時可能需要輸血。
治療方案會根據您的情況及母嬰健康來決定。

能預防懷孕晚期陰道出血嗎？
並非所有情況都可預防，但您可以採取措施降低部分風險，例如：
避免吸菸與藥物濫用。

避免容易摔倒或撞擊腹部的活動。
開車或乘車時始終繫安全帶。
遵從醫生告知您關於身體活動的指導，包括工作、運動和性生活的建議。

Vaginal bleeding between periods
月經週期間陰道出血衛教

月經週期間陰道出血的原因是什麼？
大多數人的月經每月來一次，但正常週期可以從 24 天到 38 天不等。
有時候，人們會注意到月經週期間的出血，這有時被稱為「月經間期出血」（intermenstrual bleeding）。輕微的週期間出血也稱為「點狀出血」（spotting）。
當一個人剛開始來月經時(初經)，不規則出血是正常的。隨著時間的推移，月經週期通常會變得更加規律。

可能導致月經週期間陰道出血的原因包括：
子宮、子宮頸或陰道的問題，例如息肉、感染、炎症或癌症，或是過去剖腹產（C-section）留下的子宮疤痕。
某些類型的荷爾蒙避孕方法，例如避孕藥和子宮內避孕器（IUD, Intra-uterine device）。
有時候，性行為後會發生出血；其他時候則可能找不出原因或是不可預測的。
在某些情況下，病人認為出血來自陰道，但實際上可能來自泌尿道或直腸。

我需要進行檢查嗎？
可能需要。您的醫生可能會根據您的年齡、其他症狀和情況建議檢查。他們還會進行骨盆檢查，並詢問有關出血發生的時間和量的問題。
常見檢查包括：
妊娠測試，通常在一個人的月經發生變化時進行。
子宮頸檢查（例如「子宮頸抹片檢查」或「HPV 檢測」）。
性傳染感染（STI）檢測。
腹部或陰道超音波，這利用聲波生成子宮和子宮頸的圖像，可以顯示這些器官是否有問題。
子宮組織樣本檢查。

如何治療月經週期間的陰道出血？
這取決於出血的原因。例如：
如果您有健康問題，醫生會推薦治療。例如，息肉通常可以通過手術移除；感染（包括 STI）可能需要抗生素治療。
如果您的出血與避孕方法有關，您可以選擇更換其他類型的避孕方式。

若遇到月經週期間的陰道出血，何時應該到醫療院所就醫看醫生？
若出現以下症狀時，請您到醫療院所就醫評估：
出現任何新的月經週期間陰道出血。

月經量非常多。
出現其他新症狀，例如發燒、排尿疼痛或不尋常的陰道分泌物。
您懷孕或懷疑可能懷孕(可在家自行先驗孕)。
出血前或出血期間有下腹部疼痛和嚴重痙攣。
更年期後有陰道出血情況。
若出現以上症狀請至醫療院所就醫評估治療，及早處理潛在問題。

Vertigo
眩暈衛教
什麼眩暈(Vertigo)？
眩暈是一種頭暈感，讓您感覺自己在旋轉、搖晃或傾斜，或覺得房間在您周圍移動，通常讓您感覺自己快要摔倒或昏厥，眩暈還可能讓您感到頭昏眼花，或使您難以站立行走。
根據原因，眩暈可能會反覆發作，並且可能持續幾秒鐘、幾小時或幾天。
眩暈可能由許多不同的原因引起，包括內耳問題、感染、偏頭痛、某些藥物、受傷或中風。若醫生認為您的眩暈可能不是由於嚴重的因素所造起，您可以在家裡休息恢復。

我應該如何在家照顧自己？

您應該做到以下事項：
加倍小心，避免跌倒或受傷，
如果您感到昏眩或頭暈，應立即坐下或躺下。
當您感到頭暈時，避免駕駛，如果您在開車時感到頭暈，應立即路邊停車並開啟警示燈。
如果您在頭暈時需要走路，可以使用拐杖或助行器，或者請他人幫助您走路，避免跌倒。
改變姿勢時要特別小心，避免快速改變姿勢，從坐姿到站立時要小心。
起床後，先坐在床邊幾分鐘再站起來，站立後請慢慢行走。
如果需要長時間保持坐姿或站立，記得要經常移動雙腿。
如果您被指示要做緩解眩暈的練習，請按照指示進行練習。

什麼時候需要緊急幫助？
如果您出現以下中風的症狀，請立即叫救護車送至急診尋求緊急幫助：
突然出現面部、手臂或腿部麻木或無力，尤其是身體一側
意識混亂或語言障礙，無法理解或表達
視力障礙，無法看清一隻或雙眼
走路困難、頭暈或失去平衡或協調
不明原因的劇烈頭痛
如果您出現昏厥，也請請立即至急診就醫尋求緊急幫助。
如果您無法停止嘔吐，請返回急診就醫。

何時應該到醫院就診看醫生？
您的眩暈發作時間變長或發生的頻率比以前更多。
由於眩暈，您無法走路或站立。

您持續不斷地嘔吐。
您有新的或症狀惡化的情況。